POSICIONES QUIRÚGICAS QUIRÓFANO CENTRAL HUN B

UROLOGÍA

Decúbito lateral:

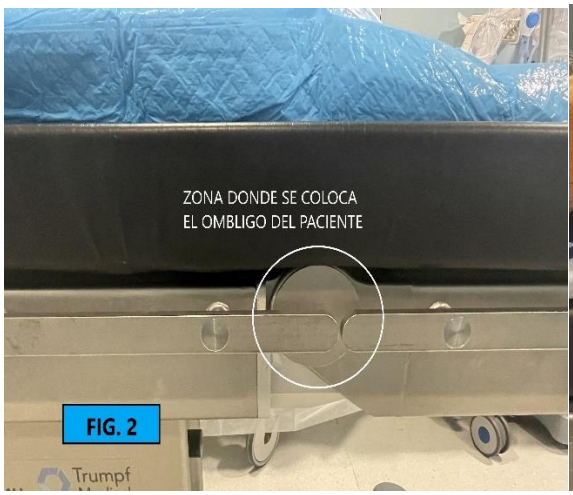
- En Nefrectomías (radicales y parciales), Suprarrenalectomías, Pieloplastias todas por laparoscopia.
  En este caso la tripa tiene que ir al borde de la camilla. Si el paciente es muy obeso la tripa quedará "colgando", siempre asegurándose de su seguridad. El que vayan con partición abdominal (Pilé), a veces depende del urólogo, y hay que poner el ombligo del paciente a la altura del círculo de la camilla. Si estas intervenciones son cirugía abierta, tiene que ir la espalda al borde de la camilla. En el caso de hacerlo decúbito lateral se colocan dos topes articulados (FIG. 1).



COLOCACIÓN DEL PACIENTE

Se parte de la posición decúbito supino (boca arriba), una vez que el paciente está anestesiado y todas las vías colocadas se procede a poner el ombligo del paciente en el círculo de la mesa (FIG. 2 y FIG. 3), una vez colocado en ese lugar se le pone al paciente decúbito lateral (de medio lado), siempre con el lado a operar hacia arriba (FIG. 4). La tripa del paciente tiene que estar en el borde de la mesa, la pierna en contacto con la mesa semiflexionada y la otra extendida. Entre las piernas se colocará un protector (chocolatina FIG. 5) para evitar roces o úlceras. Una vez realizada la colocación se procederá a poner la mesa en pilé, para ello se utiliza el mando de la mesa (FIG. 7 y 7 bis). Cuando esté hecho el pilé se pueden poner los topes articulados (FIG. 1) en la espalda del paciente, uno de ellos se coloca entre las escápulas y el otro en la parte lumbar (FIG. 8 y FIG. 9), van siempre con protector tipo huevera para evitar rojeces en la piel (FIG. 6). Los topes hay que colocarlos de manera que no molesten ni al cirujano ni a la enfermera instrumentista. Una vez colocados los topes se coloca una cincha de seguridad (FIG. 10) para evitar una posible caída del paciente. Cuando el paciente esté colocado se proceden a colocar los brazos del paciente de la manera más anatómica posible.

El brazo de arriba se coloca en la pernera tipo teja con un protector de huevera intentando que el hombro quede a la misma altura que el antebrazo e intentando que la muñeca quede bien colocada. El otro brazo se colocará en un bracero normal de quirófano, los dos brazos hay que sujetarlos con los velcros de los accesorios. Al colocar los dos brazos hay que tener en cuenta que tanto la vía aérea como las venosas estén accesibles (FIG. 11).



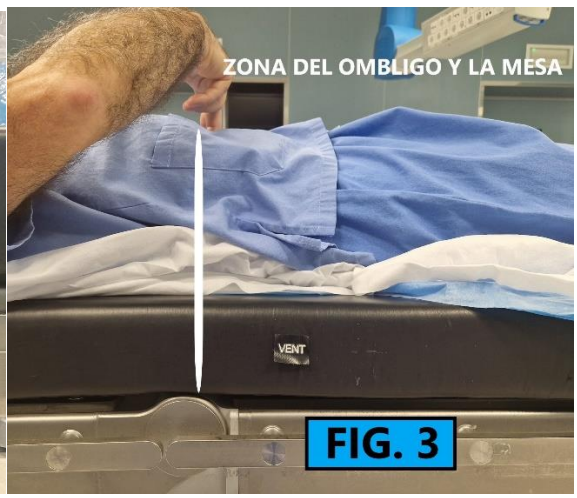



FIG.4


FIG. 5


FIG. 6



FIG. 7

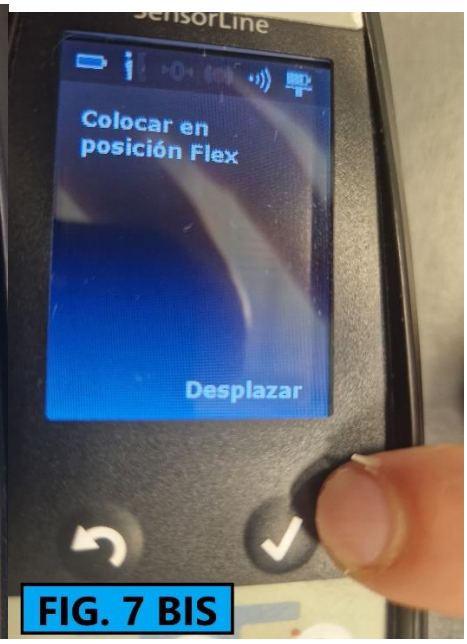


FIG. 7 BIS

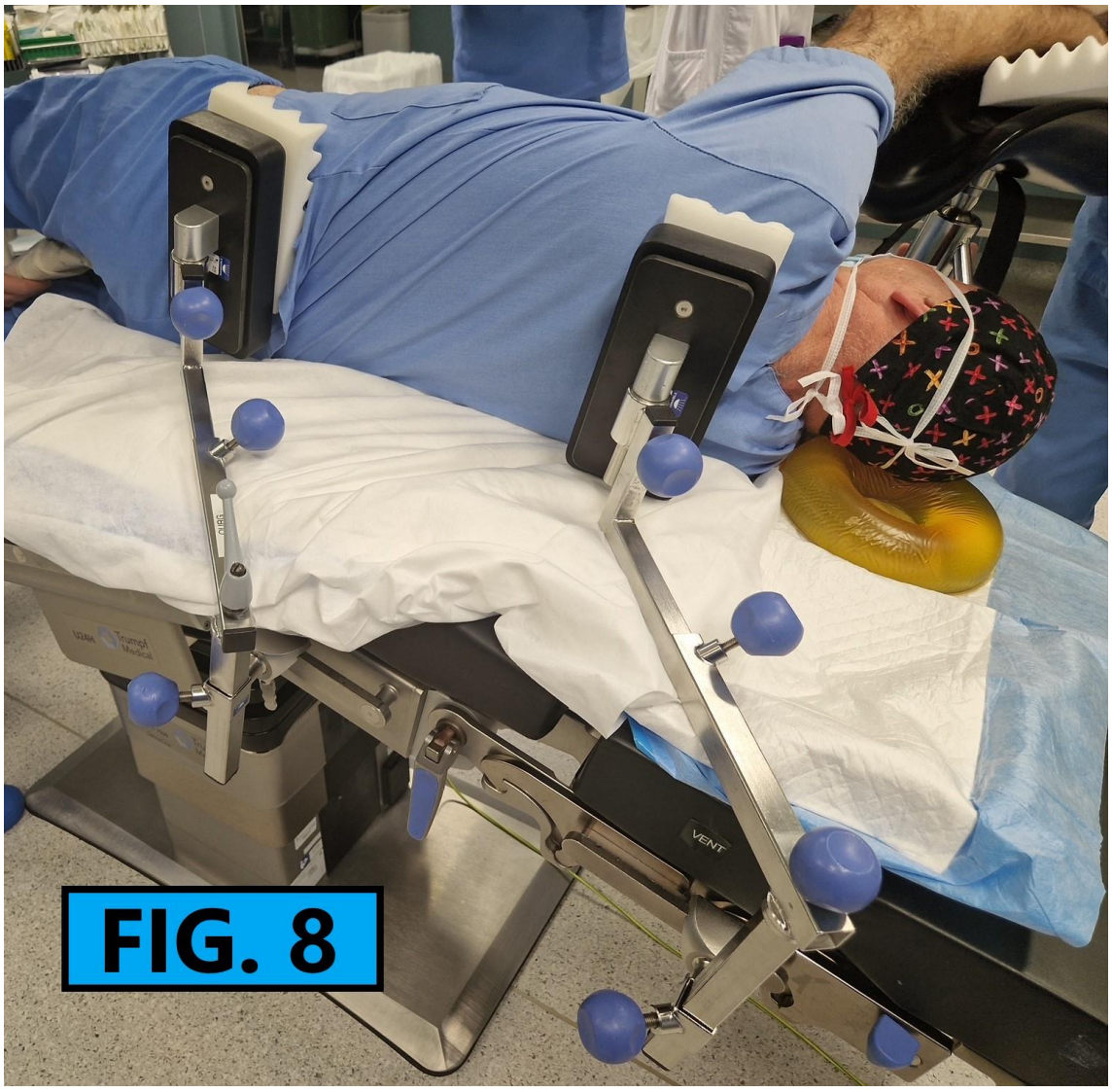
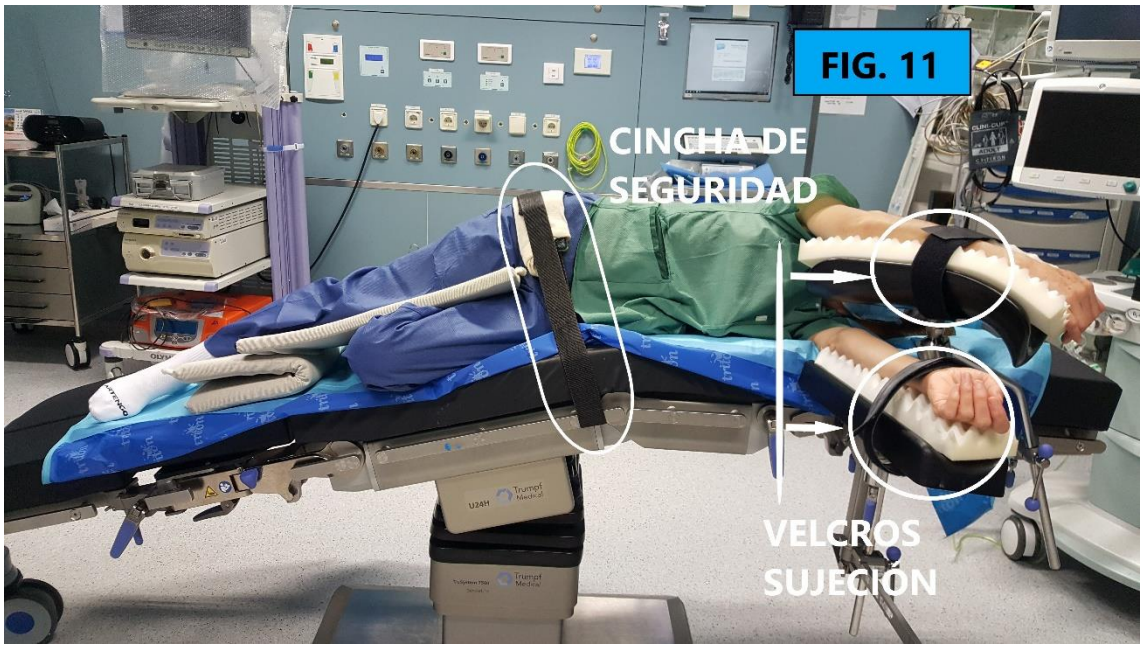


FIG. 8


TOPES EN ESCÁPULAS Y LUMBARES
ZONA DONDE SE
COLOCAN LOS TOPES
FIG. 9

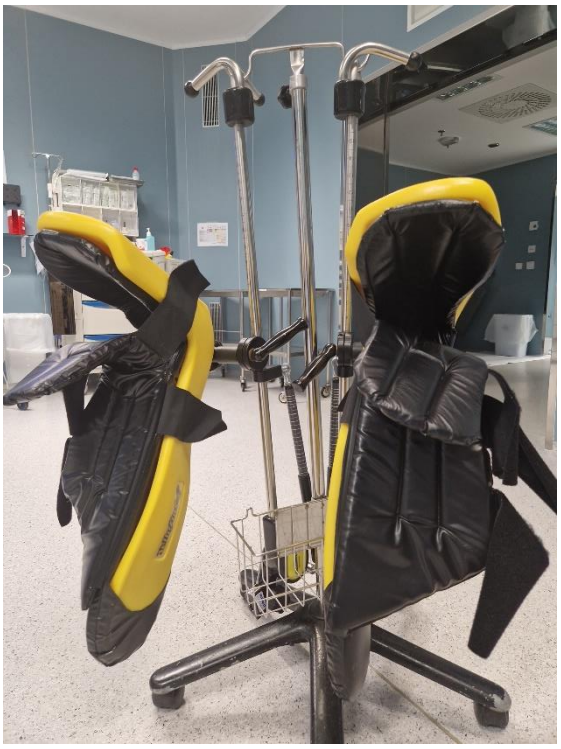

FIG. 10


FIG. 11
CINCHA DE SEGURIDAD
VELCROS SUJECIÓN



Decúbito supino:

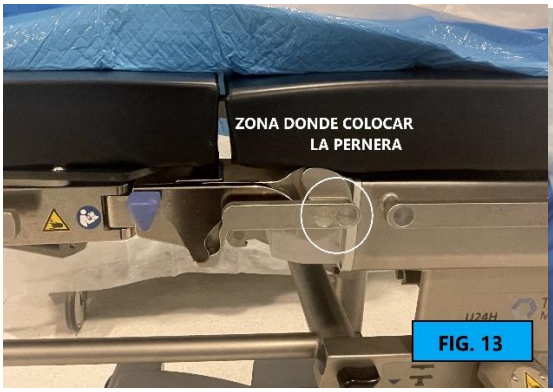
- Litotomía (con perneras): RTU, Cistoceles, Mallas en cistoceles, Inyección Botox, Rezum, Litotricia Vesical.
  El paciente tiene que tener las nalgas en el borde de la mesa de quirófano y las piernas con una posición lo más natural y relajada posible para evitar algún tipo de lesión.



COLOCACIÓN DEL PACIENTE

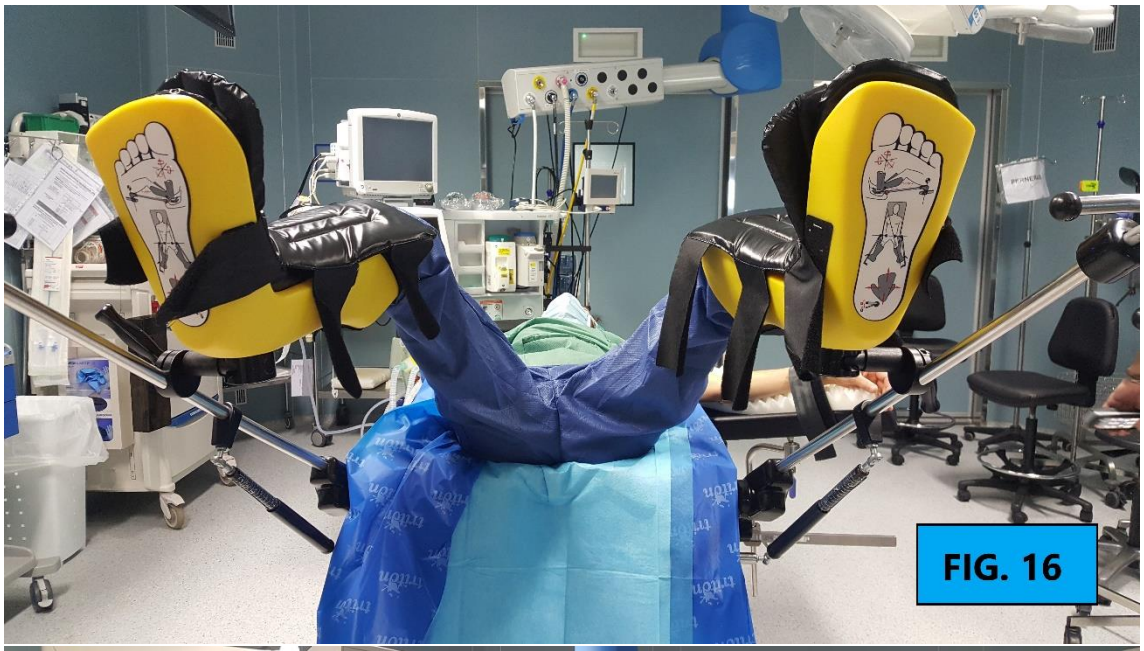
El paciente se coloca decúbito supino (boca arriba), cuando la persona responsable de la anestesia de el visto bueno se coloca al paciente con las nalgas en el borde de la parte pélvica de la mesa. Se le colocan unas medias o calcetines de “tubitón” para proteger las piernas. El personal celador colocará las perneras en la mesa, éstas se colocan con unas piezas negras que se enganchan en la mesa como una pinza (FIG.12) y se apretan con una rosca (FIG. 15). Esas piezas se ponen en la zona de la mesa donde hay dos círculos si la mesa no tiene prolongador pélvico (FIG. 13 y FIG. 14), si tiene el prolongador se coloca en la zona más cercana al cabecero de la mesa para evitar que al quitar y poner las perneras de la mesa, los gatillos para soltarlas no choquen con la pieza negra de las perneras auxiliares (FIG. 15). Una vez colocadas las perneras se bajan para subir las piernas al paciente siempre después de preguntar a la persona responsable de anestesia. Las piernas deben quedar de manera que el muslo en su cara interna quede relajado para evitar lesiones (FIG. 15 y FIG. 17).


FIG. 12
PIEZA QUE ENGANCHA
EN LA MESA


ZONA DONDE COLOCAR
LA PERNERA
FIG. 13


LUGAR DONDE SE PONE PIEZA
PARA LAS PERNERAS
FIG. 14


GATILLOS PARA
SOLTAR PERNERAS
ROSCA APRETAR
PERNERA EN LA MESA
FIG. 15

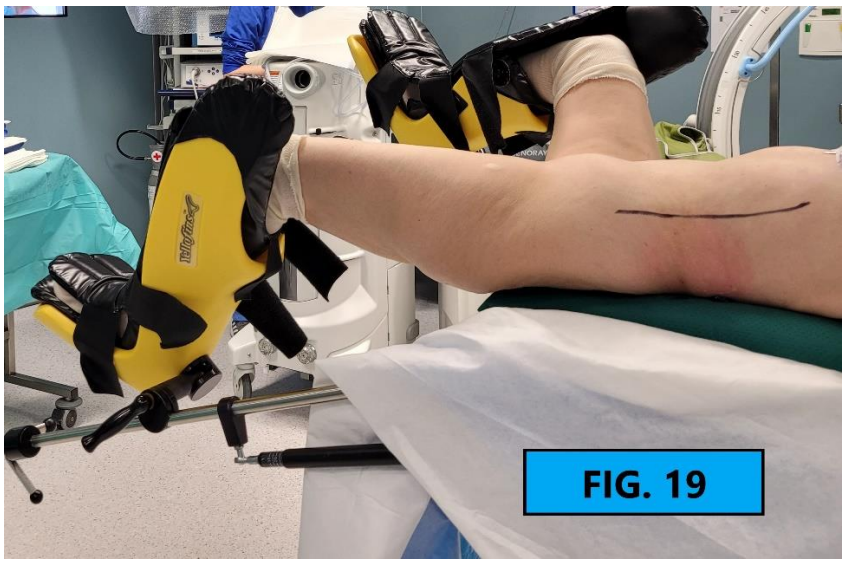




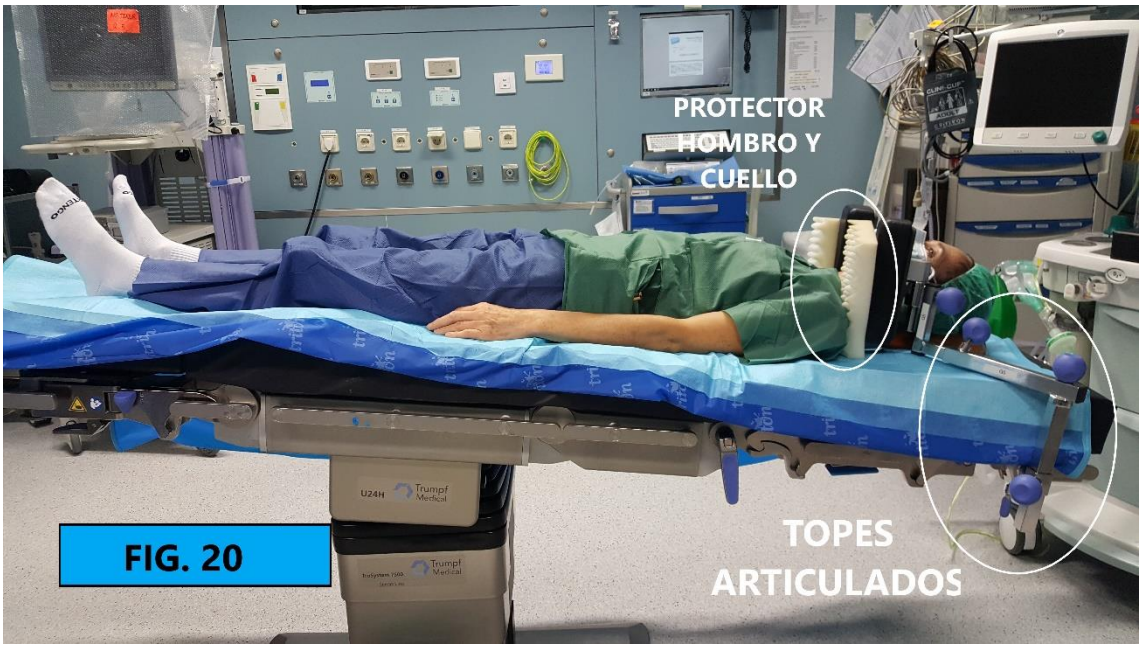
- Posición URS, que es con perneras y la pierna del lado afectada bajada: Ureteroscopias, Litotricia Ureteral.
  El paciente tiene que tener las nalgas en el borde de la mesa de quirófano y las piernas con una posición lo más natural y relajada posible para evitar algún tipo de lesión (FIG. 18).



- Posición NLP: como la de Ureteroscopia y lateralizada con rodillo en el riñón afectado.
  El paciente tiene que tener las nalgas en el borde de la mesa de quirófano y las piernas con una posición lo más natural y relajada posible para evitar algún tipo de lesión (FIG 19).



- Trendelemburg con topes: Prostatectomía radical y Cistectomía Radial por laparoscopia (en este caso los brazos van metidos por dentro sujetos con la entremetida o una sábana habilitada para tal efecto).
  Los topes articulados se colocan en la parte de arriba de la mesa de quirófano ya tenga cabecero o no, siempre con almohadillas protectoras, que cubran la parte del hombro y la cara del paciente con especial atención a mantener la vía aérea y posibles vías centrales libres (FIG. 20).



- Cirugía abierta laparotomía: decúbito supino y brazos en cruz (a veces a las nefrectomías radicales les hacen laparotomía).
  Los brazos van en cruz con los dos apoyabrazos (uno a cada lado). Importante colocarlos de tal manera que no moleste a los cirujanos/as y sobre todo que el hombro de la persona a operar no esté forzado para evitar lesiones.